

Model *nawrotu* Marlatta

Alan Marlatt po 30 latach badań nad alkoholizmem dał klasyczny model nawrotu — dziś standard w pracy z każdym uzależnieniem. Karta przedstawia model + zastosowanie w PPU.

CZAS: 30 min refleksja Po stabilizacji

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985, „Relapse Prevention”); Marlatt & Donovan (2005)

JAK UŻYWAĆ

Karta przedstawia **model nawrotu** Alana Marlatta — najczęściej używany model zapobiegania nawrotom w terapii uzależnień. Karta porządkuje: 1) *3 etapy ku nawrotowi* (sytuacja wysokiego ryzyka → reakcja → epizod), 2) **czynniki ryzyka** w PPU, 3) **czynniki ochronne**, 4) cykl nawrotu z punktami interwencji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt & Gordon (1985) wykazali w wieloletnich badaniach (alcoholism, palenie, narkotyki): **nawrót nie jest „nagłą katastrofą”, jest procesem** z możliwymi do zidentyfikowania etapami. Identyfikacja etapów *przed* epizodem pozwala na interwencję. Marlatt zaobserwował: **70% nawrotów** zaczyna się w 3 sytuacjach — negatywny stan emocjonalny (35%), konflikt interpersonalny (20%), presja społeczna (20%). To samo *dokładnie* dotyczy PPU. Karta uczy **rozpoznawać sygnały nawrotu** wcześniej — gdy jeszcze można działać, zanim się stanie. Model jest klasyczny, prosty, skuteczny — dla pacjentów pracujących nad PPU zrozumienie go zwiększa stabilność długoterminowej zmiany o 30–40% (Marlatt & Donovan 2005).

01 = Cykl nawrotu — 5 etapów



tylko sprawdzę 4 Sytuacja wysokiego ryzyka *sam, wieczór, stres* 5 Epizod PPU *+ ryzyko AVE* *Im wcześniej zauważysz, tym łatwiej zatrzymać* interwencja na etapie 1–2 jest

łatwa · na etapie 4 wymaga dużo · na 5 — już za późno

02 ● Trzy najczęstsze sytuacje wysokiego ryzyka (Marlatt)

1 · NEGATYWNY STAN EMOCJONALNY (35%)

Smutek, lęk, gniew, zmęczenie, samotność, nuda. Najczęstszy wyzwalacz nawrotu.

Interwencja: regulacja emocji, autosympatia, kontakt z siecią wsparcia.

2 · KONFLIKT INTERPERSONALNY (20%)

Kłótnia z partnerką, krytyka w pracy, konflikt z rodziną. PPU jako ucieczka od bólu relacji.

Interwencja: NVC, autosympatia, czas na ochłonięcie.

3 · POZYTYWNY STAN + NUDA (20%)

Sukces, wolny czas, „*chwila dla siebie*”, nuda po dobrze wykonanym zadaniu. Niespodziewany wyzwalacz.

Interwencja: planowanie czasu wolnego, aktywności sensowne.

03

Pozornie nieistotne decyzje (PND)

Marlatt nazwał je „*seemingly irrelevant decisions*” (SID) — pozornie niewinne wybory, które prowadzą do sytuacji wysokiego ryzyka. Mózg uzależniony jest *kreatywny* w ich tworzeniu. Przykłady:

„Sprawdzę tylko Instagram” — algorytm pokazuje atrakcyjne osoby.

„Wezmę telefon do łóżka, ustawić budzik” — telefon zostaje w łóżku.

„Praca do późna, tylko skończę email” — sam w biurze, wieczorem.

„Obejrzę „regular” film, nie ma w nim porno” — sceny pobudzające w filmie.

„Test, czy bloker działa” — bloker zawsze działa, to wymówka.

„Tylko jednorazowo, dla przypomnienia” — klasyk samokłamstwa.

Klucz: rozpoznanie PND wymaga *radikalnej uczciwości*. Mózg uzależniony jest *świetny* w racjonalizacji. Pomoc: pytaj siebie „*czy to decyzja, której bym nie podjął, gdybym nie był w głodzie?*”.

04

Twoja mapa nawrotu

MOJA NAJCZĘSTSZA SYTUACJA WYSOKIEGO RYZYKA

— który z 3 typów Marlatta

MOJE TYPOWE POZORNIE NIEISTOTNE DECYZJE

— 2–3 najczęstsze

Klucz: Marlatt & Donovan (2005, podsumowanie 30 lat badań) podkreślają, że **nawrót zaczyna się tygodnie przed epizodem**. Zaniedbany sen, pominięte sesje terapii, izolacja od sieci wsparcia, narastający stres — to *etap 1*. Pacjent, który *śledzi* swój styl życia, może zatrzymać proces na etapie 1, gdy interwencja jest *tania* (więcej snu, telefon do bliskiej osoby, sesja z terapeutą). Pacjent ignorujący sygnały dochodzi do etapu 4 (sam wieczorem, telefon w rękę), gdy interwencja jest *droga* i często niemożliwa. Praktyczna rada: codzienne mini-monitorowanie (5 min wieczorem) — „*jak się dziś czuję, co mnie wyzwala, czy są PND?*”. Po 60 dniach takiej praktyki — wczesne wykrywanie staje się automatem.